EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 86393
SERVICIO : MEDICINA HSC
FECHA : 2024-06-11 08:54:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: UBERLINDA DE LAS ROS CONCHA VASQUEZ			RUN	: 8.066.240-8
F.Nac	: 20-01-1959	Edad	: 65 AÑOS, 4 MESES	Género	: Femenino
Dirección	: LA NUEVA VIDA PASAJE LA LUNA 676			Comuna	: SAN CARLOS
Previsión	: FONASA B	Teléfono	: 992639690		
Fecha Ingreso	: 2024-06-05	Fecha Egreso	: 2024-06-11 08:54:00	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. J20-BRONQUITIS AGUDA.

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

Insuficiencia respiratoria Resuelta
Bronquitis aguda
-IC (FEVI conservada)
-DM2NIR
-ACV secuelar
-UPP sacra
-Limitación severa ABVD
-TEP en TACO
-ITU 2ria a E, faecium tratada

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. J15.9-NEUMONIA BACTERIANA, NO ESPECIFICADA (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Paciente femenina de 65 años postrada Deterioro Neurocognitivo probable origen vascular. con antecedente mórbidos ACV, DM, EPOC, TEP en TACO, multiples hospitalizaciones por cuadros respiratorios. Actualmente en HODOM tras ser dada de alta hace 5 días por SDRA.
Es traída nuevamente por fiebre, disnea, desaturaciones en domicilio, secreciones amarillentas y compromiso del estado general. Se realiza exámenes destaca :Crea 0.5 Lactato 1.5 LDH 300 PCR 463.5 ELP 134/5.1/10 Hb 10.1 Leucocitos 19400 INR 1.08 Panel viral (-) GSA pH 7.47 pCO2 35.9 pO2 74.8 HCO3 26.6 Sat 92% Fio2 al 30%.
TAC de torax: Bronquiolitis celular de probable etiología infecciosa/inflamatoria en ambos pulmones. Focos de condensación en ambos pulmones lobulos inferiores, determinados en parte por fenomenos atelectasicos en contexto de secreciones en via aerea correspondiente y adquisicion espirada. Cambios inflamatorios bronquiales bilaterales. Ateromatosis aortica y coronaria. Se ingresa para manejo,.
Evoluciona favorablemente, con disminución de los parámetros inflamatorios, se rescata Cultivo Corriente Positivo -Pseudomonas aeruginosa - Streptococcus pneumoniae -Staphylococcus aureus.
Exámenes control 10-6-24 Creatinina : 0,30 Clearence Calculado(MDRD) : 223,27 Lactato : 1,2 Proteina C Reactiva : 54,6 Sodio (Na) : 142,00 mmol/L Potasio (K) : 4,80 mmol/L Cloro (Cl) : 105,00 leucocitos : 11,40 mil/ul Recuento Hematies : 3,59 * Mill/ul Hematocrito : 30,8 * o/o
Hemoglobina : 9,6 * g/dl Plaquetas : 491.
Ta en condiciones de lata domicilio, se coordina oxigeno domiciliario por la unicidad de cuidados universales.

PLAN DE MANEJO:

hospitalizar en hodom
meropenem 1 gr cada 12 horas por 1 dias

kine

INDICACIONES AL ALTA

1. Regimen Por Sng + Agua 200 Cc C 4hrs (Indicaciones Por Nutricion)
2. Limpieza De Cavidad Oral, Mojar Labios Y Lengua Con Algodón Embebido En Agua
3. Knt Respiratoria Y Motora 2 Veces Al Dia
4. Manejo Y Aspiración De Secreciones
5. Ins Nph 22u Am - 12 U Pm Sc
6. Meropenem 1 Gr C/12 Hrs Por 1 Dia Ev
7. Vitamina Tol 12 1 Amp Im Por Semana O Cada 5 Dias
8. Dabigatran 110 Mg Unidad Unidad 1 Unidad Cada 12 Hrs. Via Oral
9. Famotidina Comprimido 40 Miligramos 1 Comprimido Cada 24 Hrs. Via Oral
10. Carvedilol Comprimido 6,25 Miligramos 1 Comprimido Cada 12 Hrs. Via Oral
11. Levetiracetam Comprimido 500 Milígramos 1 Comprimido Cada 12 Hrs. S Via Oral
12. Amitriptilina Comprimido 25 Miligramos 1 Comprimido Cada 24 Hrs. Via Oral, Noche
13. Quetiapina Comprimido 25 Miligramos 1/2 Comprimido Cada 24 Hrs. Via Oral, Noche
14. Atorvastatina Comprimido 40 Miligramos 1 Comprimido Cada 24 Hrs. Via Oral
15. Ipratropio Inhalador Frasco Unidad Via Inhalatoria; 2 A 4 Puff C/6 H
16. Fluticasona/Salmeterol Inhalador 250 Microgramos / 25 Microgramos Via Inhalatoria: 2 Púff C/12 H
17. Paracetamol Comprimido 500 Milígramos 2 Comprimido Cada 8 Hrs. Via Oral, Sos Si Dolor O Fiebre

CARABALLO DE HURTADO
JENNIFER DEL CARMEN
MEDICO TRATANTE
26251544-3

JEFE SERVICIO